

Historia Clínica Digital

Reporte clínico consolidado de citas y exámenes del paciente.

PACIENTE

Sofía Artemisa Cruz Arcos

GÉNERO

Femenino

NACIMIENTO

23/3/2026

EDAD

0 años, 1 meses, 12 días

Registros clínicos

Sin filtros aplicados

Fecha	Tipo	Clínica	Doctor	Estado	Resumen
4/5/2026, 11:24:00 p. m.	Cita	Hospital Militar - HE1	Sin nombre - emergencia - HE1 · Pediatría	realizada	INGRESO POR EMERGENCIAS a las 23:30 Paciente femenina de 1 mes y 11 días de edad es llevada a emergencias por episodio de llanto persistente desde aproximadamente las 17:00 hasta el momento de la consulta. Se reporta cambio reciente de alimentación en las últimas 5 horas a fórmula Blemil arroz hidrolizado. A la valoración presenta temperatura de 37.2 °C, sin otros signos de alarma, evidenciándose cuadro compatible con cólicos intensos. Durante la atención se realizan medidas físicas para facilitar la expulsión de gases durante un tiempo extenso como mover las piernas y masajes, con mejoría parcial. Se indica retomar lactancia materna, continuar con simeticona según esquema previo y evitar cambios frecuentes de fórmula, considerando que esto puede empeorar la sintomatología. Se recomienda realizar exámenes de alergia para descartar alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) y mantener vigilancia de la evolución clínica.
2/5/2026, 11:46:00 p. m.	Cita	Hospital Militar - HE1	Sin nombre - emergencia · HE1 - Neonatología	realizada	Paciente femenina lactante es llevada a servicio de emergencias tras presentar episodio de irritabilidad intensa con llanto continuo desde aproximadamente las 07:00 hasta las 23:00 horas, asociado a escaso descanso durante el día. A la valoración clínica se encuentra afebril, sin datos de alarma, y se determina

Fecha	Tipo	Clínica	Doctor	Estado	Resumen
					cuadro compatible con cólico del lactante. Se indica continuar con simeticona según esquema previamente establecido, añadir paracetamol 12 gotas vía oral cada 6 horas según necesidad, y evitar la sobrealimentación como medida para disminuir la sintomatología. Se brindan recomendaciones generales de manejo del cólico y vigilancia de la evolución clínica en domicilio.
28/4/2026, 10:36:00 a. m.	Cita	Hospital Metropolitano	Dr Fabian Vasconez · Pediatría Gastroenterología	realizada	Peso: 3740 g - Talla: 51.5 cm evaluada en consulta de gastroenterología pediátrica. Presenta granos en la cara, dolor abdominal con episodios en los que se arquea, aletea brazos y se retuerce, además de deposiciones de color amarillo. Al momento de la valoración no se identifican signos de alarma. El cuadro clínico es compatible con posible alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), considerándose que el reflujo observado forma parte de esta condición. Se indica iniciar manejo con fórmula extensamente hidrolizada (Nutrilon Pepti Syneo) a libre demanda, suspendiendo la lactancia materna de forma temporal por una semana mientras se realiza proceso de desintoxicación materna, recomendando continuar la extracción de leche durante este periodo para mantener la producción. Se prescribe además Lactobacillus reuteri (Biogaia) 5 gotas vía oral una vez al día, y simeticona (Gasrelief) 5 gotas vía oral en cada toma o en caso de presentar muchos gases. Para la madre se indica calcio (Calcibon D) 1 tableta diaria. Como parte del manejo no farmacológico, se establece dieta estricta para la madre sin lácteos ni derivados, sin fideos o pasta, sin carne de res, sin soya, sin alimentos procesados que puedan contener trazas de leche, sin pan ni galletas (excepto si son hechos en casa) y sin cubos tipo Maggi. Se planifica control en una semana para reevaluación de la evolución clínica.
22/4/2026, 8:00:00 a. m.	Cita	Hospital Militar - HE1	Dra Lupe Nicolalde · HE1 - Neonatología	realizada	PESO: 3780 g - TALLA: 51,3 cm - PERÍMETRO CEFÁLICO: 36 cm Recién nacida llevada a control por episodios de reflujo, irritabilidad y consulta general. Durante la valoración se determina que el reflujo es de tipo fisiológico, probablemente asociado a sobrealimentación y a un flujo rápido de leche debido a succión vigorosa, sin evidencia de reflujo patológico.

Fecha	Tipo	Clínica	Doctor	Estado	Resumen
					Se recomienda mantener medidas posturales posteriores a la alimentación, incluyendo posición vertical por aproximadamente 15 minutos, realizar pausas durante la toma para evitar sobrecarga y favorecer la expulsión de gases, así como continuar con el uso de almohada antirreflujo. En relación con la ictericia neonatal, se realiza medición de bilirrubina transcutánea con resultado de 8.1, valor dentro de parámetros normales para la edad, observándose leve coloración amarillenta en resolución. Al examen físico, la fontanela anterior se encuentra dentro de parámetros normales. Se reporta secreción vaginal mucosa de color amarillento, atribuida a influencia hormonal materna, considerada fisiológica. Se indica: -Continuar con Simeticona a dosis de 10 gotas cada 12 horas y mantener la administración de BioGaia. Se planifica control médico en un mes y se recomienda vigilancia de la evolución clínica y tolerancia alimentaria.
17/4/2026, 4:00:00 p. m.	Cita	Pediatría Sangolquí	Dra Fanny Rosas · Pediatría	realizada	Talla: 55cm - Peso:3500 g - Perímetro Encefálico: 35,2 cm. La bebé se encuentra un poco arriba del promedio de talla. No presenta reflujo patológico. Recomienda almohada antireflujo. No recomienda medicina por ahora. Ver receta
8/4/2026, 11:47:00 a. m.	Cita	Hospital Militar - HE1	Dra Lupe Nicolalde · HE1 - Neonatología	realizada	Talla: 50cm - Peso: 3220g - Perímetro Craneal: 34.4 cm Cita de control, disponen extraer el oxígeno por varias horas al día y controlar con el saturador. Se autoriza la toma de fórmula confort. Se autoriza tomar BIOGAIA como ayuda para los cólicos. La saturación es sobre 89% a pesar que se encontraba succionando. Buen agarre y buena succión.
3/4/2026, 9:16:00 a. m.	Cita	Pediatría Sangolquí	Dra Fanny Rosas · Pediatría	atendida	Recién nacida con talla de 50 cm y peso de 3100 g, llevada a consulta para control general y por presentar irritabilidad e incomodidad durante la lactancia. Al examen físico, que incluyó valoración de caderas, ombligo y parámetros generales, no se evidencian complicaciones ni alteraciones estructurales. Se establece diagnóstico de taquipnea transitoria del recién

Fecha	Tipo	Clínica	Doctor	Estado	Resumen
					nacido, motivo por el cual se mantiene oxigenoterapia con indicación de destete progresivo: durante la primera semana 45 minutos con cánula y 15 minutos sin, en la segunda semana 30 minutos con y 30 minutos sin, y en la tercera semana 45 minutos con oxígeno y 15 minutos sin. Se recomienda además el uso de oxígeno en horario nocturno desde las 18:00. En relación con la irritabilidad y el malestar abdominal, se identifican cólicos del recién nacido asociados a acumulación de gases, evidenciados en radiografía. Se indica cambio a fórmula tipo confort, administración de simeticona en gotas para el manejo de gases y paracetamol en caso de dolor, según necesidad. Próxima cita en un mes.
31/3/2026, 11:00:00 a. m.	Examen	Hospital Militar - HE1	-	-	Exámenes que le realizadon en el hospital militar, no encontraron nada malo.
31/3/2026, 10:00:00 a. m.	Cita	Hospital Militar - HE1	Sin nombre - emergencia · HE1 - Neonatología	atendida	Peso: 3100g Talla: 49.5 cm Luego de haberle revisado en el Centro de Salud de Selva Alegre por posibles cólicos, el doctor indica una posible neumonía por aspiración luego de escuchar los pulmones y medir 39 grados de temperatura en el abdomen, nos dirige al hospital militar. En el camino al hospital militar se baja la fiebre con una botella de agua fria. En el hospital militar realizan exámenes de sangre y rayos x de torax, descartan infección y neumonía, le dan el alta ese mismo día. Temperatura normal, latidos del corazón altos que luego disminuyeron. Próxima cita en neonatología el 08 de abril de 2025
30/3/2026, 12:10:00 p. m.	Cita	Hospital Militar - HE1	Dra Lupe Nicolalde · HE1 - Neonatología	atendida	----- ALTA HOSPITALARIA ----- Le dan el alta luego de 5 días de hospitalización, luego de haber descartado infección (Que era la razón por la cual estaba internada.) Sale con ayuda de oxígeno de 0.2 L/m debido a que satura bajo por posible líquido en los pulmones.

Fecha	Tipo	Clínica	Doctor	Estado	Resumen
					De acuerdo a libreta de vacunación (adjunto) cuando nació tenía 2815g, longitud: 45 cm y longitud cabeza: 32 cm. Vacunas colocadas: BCG (Meningitis) y Hepatitis B
28/3/2026, 9:00:00 a. m.	Cita	Hospital Militar - HE1	Dra Johana Erazo · HE1 - Pediatría	atendida	Según indicó la doctora: en la noche madrugada del 27 al 28 de marzo, Sofía se puso morada y le pusieron oxígeno, pasó con oxígeno la madrugada y en la mañana le intentan retirar, pero aún saturaba bajo, por lo que determina que debe irse con oxígeno a la casa y van a retirarle progresivamente. Indicaciones: La dosis es de 0.3 litros por minuto las 24 horas del día por tiempo no determinado.
26/3/2026, 10:01:00 a. m.	Cita	Hospital Militar - HE1	Dra Lupe Nicolalde · HE1 - Neonatología	atendida	PESO AL NACER: 2815 g TALLA AL NACER: 48 cm PERÍMETRO CEFÁLICO AL NACER: 32 cm Diagnósticos: RN a término (RNAT), peso adecuado para edad gestacional (PAEG), sospecha de sepsis neonatal en estudio. Escalas: SNAP-II 0, SNAPPE-II 0, mortalidad estimada 0.3%, score de choque 0. Estado general: hemodinámicamente estable, piel rosada. Neurológico: activa y reactiva, sin focalidad neurológica. Respiratorio: autonomía respiratoria, saturación adecuada, buena ventilación bilateral, sin ruidos patológicos. Cardiovascular: tensión arterial > percentil 50, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos. Digestivo: alimentación enteral progresiva 30 cc cada 3 horas (leche materna + fórmula), tolerancia regular, succión lenta, reflejo nauseoso sin vómito. Abdomen blando, depresible, no doloroso, ruidos hidroaéreos presentes. Ingesta calórica 45.7 kcal VO. Infeccioso: perfil infeccioso por clínica digestiva desfavorable y antecedentes maternos (vaginosis e infecciones urinarias recurrentes). Resultados: leucocitosis y elevación de reactivantes de fase aguda. Conducta: inicio de antibioticoterapia de primera

Fecha	Tipo	Clínica	Doctor	Estado	Resumen
					línea. Metabólico: adecuada termorregulación, eliminaciones fisiológicas. Parámetros: LT 87.4, I 3.6, DH 1.8. Análisis: recién nacida a término, estable, sin compromiso respiratorio ni neurológico. Dificultad leve en alimentación. Manejo antibiótico por sospecha infecciosa y vigilancia clínica estrecha. Plan: vigilancia neurológica, respiratoria y digestiva; continuar antibioticoterapia; mantener alimentación enteral progresiva; monitorizar signos de deterioro clí